

43. 토혈

- **중요 포인트 2 가지!**
 - 1. 객혈과 토혈을 우선적으로 감별!
 - 2. 토혈의 양과 응급 증상 등으로 응급 처치 여부를 결정

• Overview

- 1. 병력청취
 - 객혈과 토혈을 감별, 토혈의 양상
 - 응급 증상 확인 + 전신, 출혈 경향성!, 소화기
 - 음주 관련 질문 (말로리-바이스), 간질환 관련 질문, 식사 관련 질문 (GERD, 궤양)
- 2. 신체진찰 - 혈압측정, 정맥 주사, 안전 수혈 술기
 - V/S 확인: 혈압 + 맥박 확인
 - 코와 입에서 출혈 확인
 - 손: 시진 상 이상 없는지, flapping tremor 확인!
 - 전신 + 복부 + 간/비장, 복수 + DRE!
- 3. 교육
 - 안심: 피와 관련되었기 때문에 환자 공포감 안심시켜 주기!
 - 응급: 어지러움, 다시 피를 토함, 짜장면 같은 검은 변 시 즉시 내원 / 수액공급 및 수혈 필요성
 - 아스피린/NSAIDs(진통제) 복용 확인 후 중단
 - 내시경 교육 / 필요 시 혈관조영술, 외과적 치료

• 평가 목표

원인		
궤양/미란		위궤양/십이지장궤양, 궤양 천공
문맥고혈압		식도정맥류
종양		식도암, 위암
기타 원인		말로리-바이스 증후군, 혈관 기형, 응고 장애
평가목표		
1) 병력청취와 신체진찰로 혈액학적 안정성과 출혈의 지속성을 신속하게 판단하여 응급 처치 여부를 결정		
2) 출혈의 원인을 찾기 위한 진단 및 치료 계획을 수립		
구체적인 성과		
병력 청취	객혈/비인후강 출혈/토혈 감별	객혈: 거품, 기침, 가래가 섞임, 선홍색 비인후강 출혈: 코나 입에서 피가 나옴, 선홍색 토혈: 구토와 함께 나옴, 음식물과 혼합됨, 검붉은색
	실혈의 정도와 지속성을 평가	실혈의 정도: 직접적인 양(종이컵), 전신 증상 - 어지럼/두근거림/숨 참/소변량 감소 (탈수, 쇼크) 실혈의 지속성: 배변 양상 확인(흑색변)
	토혈의 유발 요인과 원인 확인	유발 요인: 식사, 과음 후 반복 구토(말로리-바이스), 약물(NSAIDs/아스피린), 간질환 병력 원인: 전신, 소화기(복부/식도정맥류)
	출혈성향의 유무 확인	멍이 잘 들, 피가 잘 안 멎음, 잇몸피, 월경량 변화
신체 진찰	활력 징후 및 실혈량을 파악하여 응급 및 중증 여부를 판단	V/S 확인: 저혈압, 빈맥 눈(빈혈), 혀와 구강 점막의 건조도 및 피부 탄력성 저하 출혈: 혈압, 맥박 확인
	원인 감별을 위해 필요한 신체진찰	구강/비강 내 출혈 확인 (코, 입) 복부: 압통(궤양), 거미혈관종/복수/간비대(간경화), 종괴(암) DRE: 흑색변 여부 직접 확인

		손: palmar erythema, flapping tremor
진단	실혈량 평가를 위한 검사계획	혈액검사 CBC(Hb 저하), 전해질, BUN/Cr
	출혈성 질환에 대한 평가를 위한 검사계획	간기능검사, 혈액응고검사 LFT, PT/INR (정맥류 및 지혈 장애 확인)
	원인질환을 감별할 수 있는 검사 계획	위식도내시경 - 출혈 부위 확인 및 즉시 지혈 시술 가능 CXR, 복부 X-ray
치료	출혈의 원인에 따른 기본 치료계획	금식(NPO), 안정, 비위관 삽입(필요 시 위 세척) 위식도내시경 - 필요 시 출혈 부위 확인 및 즉시 지혈 시술 가능 - 궤양/미란: 양성자 펌프 억제제(PPI), H.pylori 치료 - 식도정맥류: 결찰술 - 암: 내시경적 지혈, 조직검사, 외과적 치료 - 말로리-바이스 증후군: NPO + 수액
	출혈 정도에 따른 응급 처치 + 수혈이 필요한 환자에게 조치	대량 수액 요법(N/S, 링거액), 필요 시 농축적혈구(RBC) 수혈
	응급 시술이나 응급 수술이 필요한 환자에게 조치	내시경적 지혈 외에도 혈관조영술, 외과적 치료가 필요할 수 있음을 설명
환자 교육	토혈이 발생할 경우 응급 처치와 내원의 필요성을 설명	어지러움, 다시 피를 토함, 짜장면 같은 검은 변 시 즉시 내원 술, 담배, 아스피린/NSAIDs(진통제) 복용 중단 안내
	응급처치나 수술이 필요한 경우, 환자의 불안감을 배려하면서 설명	피와 관련되었기 때문에 환자 공포감 안심시켜 주기

● 원인 질환 정리

질환		질환 설명	병력청취	신체진찰	검사	치료
궤양/ 미란	위궤양/십 이지장궤 양 2+1 1+0	위나 십이지장에 염증이 생겨 점막에 상처가 생겨 출혈이 생김	멍치 통증, 속쓰림 식사와 관련 (십이지장은 x) 흑색변 NSAID 유발 궤양	상복부 압통 (없을 수 있음)	식도위내시경 조직검사 신속 요소분해효소 검사	양성자펌프억제제(PPI) 제균치료 NSAID 복용 중단
	궤양 천공	위의 염증이 생긴 부위에 구멍이 생김	궤양 증상 + 심한 복부 압통 및 반발압통 복벽 경직	복부 압통 및 반발압통 복벽 경직	가슴 X 선	응급 수술
문맥 고혈압	식도정맥 류	간경변증에 의해 피가 간을 통과하지 못해 우회로(정맥류) 형성 후 파열	간염/간경변 진단 간염/간경변 증상 많은 양의 토혈	caput medusa palmar erythema 복수 flapping tremor	식도위내시경 간기능검사	내시경 정맥류 결찰술 BB (예방)
암	식도암	식도에 생긴 신생물	담배, 나이 많음 연하곤란 체중감소	-	식도위내시경 CT	수술, 방사선 치료
	위암 0+1	위에 생긴 신생물	소화불량, 속쓰림 체중 감소	-	식도위내시경 CT	수술, 항암 치료
기타	말로리- 바이스 증후군 3+1	심한 구토 시 위- 식도 접합부 점막이 찢어짐	음주 후 구토하는 중 토혈	-	식도위내시경	금식, 수액치료 필요 시 내시경적 지혈
	응고장애	출혈 경향에 의해 피가 남	출혈 경향	-	식도위내시경	NSAID, 아스피린, 항혈소판제 등 복용

						중단
	역류식도 염	위산이 식도로 역류해 염증	소량의 피 신물이 올라옴, 속쓰림	-	식도위내시경 24 시간 식도 PH 검사	양성자펌프억제제(PPI) 생활습관 교정

O	언제 / 갑자기 (언갑서 상황) 당시 어떤 상황					
L	-					
D	몇번					
Co	처음보다 심해지나요?					
Ex	이전 경험 - 치료					
C	개방형: “어떻게 아픈지 자세히 설명해주시겠어요?” 객혈과 감별) 기침 / 가래 / 코나 입 / 음식물 양상) 색 / 양(종이컵) / 거품 / 피떡 정도) 일상생활에 지장 (-> 공감 PPI)					
A	개방형: “다른 불편한 곳은 없으세요? 네. 그럼 제가 몇가지 자세하게 확인해보겠습니다.” 전신) 발열/오한/체중변화/피로/부종/식욕부진 r/o 암 응급/탈수) 목마름/어지럼/두근거림/숨 참/소변량 감소 출혈) 멍이 잘 들, 피가 잘 안 멎음, 잇몸피, 월경량 변화 소화) ANauseaVomitingConstipationDiarrhea HMMH SPHD 1 N/V/A /복통/명치통/속쓰림/소화불량 2 변비/설사, 혈변/흑색변/지방변 3 황달/가려움/소변량 변화 + 신물 올라옴/속쓰림/연하곤란					
F	개방형: “증상이 어떨 때 좀 괜찮아지고/심해지나요?” 전날 음주, 과음 통증이 있다면 식사와 관련? r/o GERD					
E	마지막 건강검진? (위/대장내시경) 간염 예방접종					
과	현재 앓고 계신 질환이 있나요? 기본 : 고혈압/당뇨/고지혈증/결핵/간 소화기 질환 진단					
외	다치거나 수술받은 적이 있나요? (특히 복부)					
약	복용중인 약물? NSAID, 소염진통제, 아스피린(피를 묽게하는 약물)					
사	기본 : 음주/흡연/커피/직업/스트레스/운동 식습관) 평소 식사 규칙적? 기름지고 자극적인 음식 좋아하나요? 식후에 곧바로 눕나요? 운동) 운동 규칙적으로 하시나요? 일주일에 몇번 정도 하세요?					
가	(소화) 비슷한 증상, 소화기질환 / 간질환 / 암					
여	규칙적, 임신 가능성					
PEx	동의 구하기 손 씻기					
	기본	V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) > 나중에 수액/수혈 필요할 수 있습니다. 1 눈: 빈혈, 황달 2 코: 비경 사용해서 비강 내 출혈 확인! 3 입: 탈수 + 구강 내 출혈 + 인두 피떡 4 목: 경부 림프절 + 갑상샘 5 손: palmar erythema, flapping tremor 6 사지 : 피부 긴장도, 다리부종				

	복부 복부 - 자세 누워서 무릎 굽힘, “가슴부터 골반까지 노출하고 다른 부위는 가려드리겠습니다.” - 시진 - 외상+수술흔적+팽만+ 특이적으로 나온 혈관(거미혈관종 - 가슴까지 올려주세요/ caput medusa) - 청진 (1 군데 당 3-5 초)-타 (먼 곳부터)-촉(먼 곳부터) * 환자 수치심이 들지 않도록 잘 설명, 가려주기 간, 비장 진찰: 촉진, 타진 복수 타진 DRE - 원인을 정확하게 파악하기 위해 항문에 직접 손을 넣어 만져보는 직장수지검사를 시행하려고 합니다. 괜찮을까요?	
	혈압측정 *임상술기*	
	협조해주셔서 감사합니다. 불편한 건 없으셨나요? 손씻기 공감/안심) 갑자기 ~ 증상이 나타나서 불편하고 걱정 많으셨겠습니다. 추정진단) 지금까지 문진과 신체검진 결과를 종합해 보았을 때 ~~가 의심됩니다. 기전설명) 해당 질환은 ~~ 으로 해당 증상이 나타날 수 있습니다. 감별진단) 하지만 이 외에도 ~~등의 질환도 배제할 수 없어 추가적인 검사가 필요합니다.	
	기본!! + 여성	혈액검사, 간기능검사, 혈액응고검사 식도위내시경 임신반응검사 금식 및 안정, 수액요법
	응급!!	대량 수액 요법, 필요 시 농축적혈구 수혈
	위 궤양/십이지장 궤양	식도위내시경, 요소날숨검사 헬리코박터균 확인 위산 줄여 염증 줄이는 약물 (양성자 펌프 억제제, 위점막보호/제산제)
	식도정맥류	식도위내시경 내시경적 결찰술, 필요 시 혈관조영술, 외과적 치료
	종양	조직검사, 복부 영상 검사 (xray, CT) 수술, 항암치료
	말로리-바이스 증후군	식도위내시경 금식 및 안정, 수액요법 (이후 피 계속 나오면 내시경적 지혈)
교육	(안심/응급/술담커식운수스/검진접종) [안심] 피와 관련되었기 때문에 환자 공포감 안심시켜 주기! [회피/교정] 생활습관 교정 술, 담배, 아스피린/NSAIDs(진통제) 복용 중단 안내 내시경 검사 필요하고 지혈 치료할 수 있음 설명 - 내시경 전 8 시간 금식 유지 교육 내시경적 지혈 외에도 혈관조영술, 외과적 치료가 필요할 수 있음을 설명 - 환자의 불안감을 배려하며 설명 [검진/접종] 간염예방접종, 주기적 내원 [응급] 어지러움, 다시 피를 토함, 짜장면 같은 검은 변 시 즉시 내원 출혈 심하여 빈혈 소견 보이는 경우 수액 공급이나 수혈 필요함 설명	
PPI	궁금하신 점 있으실까요?	